เรือนไฟ

เพื่อนคู่ใจของแม่หลังคลอด บอกว่าอยู่ไฟแบบไหนได้ เมื่อไร และจองได้ที่ไหน ตั้งแต่วันคลอดจนครบ 3 เดือน

ข้อเสนอแนวคิด — DTAM Thai Traditional Medicine Digital Health & AI
Track: ผดุงครรภ์ไทย | ทีม: เรือนไฟ

บทสรุปผู้บริหาร

> *ตัวอย่างสมมติ:* คุณแม่คนหนึ่งผ่าคลอดมาได้ 3 สัปดาห์ อยากทับหม้อเกลือ แต่ไม่รู้ว่าทำได้หรือยัง ไม่รู้ว่าหน่วยบริการใกล้บ้านว่างวันไหน และไม่รู้ว่าสิทธิ์ฟื้นฟูหลังคลอดของตัวเองใช้ได้กี่ครั้ง ถึงวันไหน

ตามแผนผังมาตรฐาน การคัดกรองเริ่มเมื่อคุณแม่ไปถึงหน่วยบริการแล้ว **เรือนไฟตอบได้ตั้งแต่ยังอยู่ที่บ้าน และพาไปถึงการนัดหมายที่ผ่านการคัดกรองแล้ว** เช่น บอกว่าผ่าคลอดต้องรอครบ 1 เดือน ทับหม้อเกลือเริ่มได้วันที่ 30 ให้จองได้เฉพาะวันที่อยู่ในกรอบเวลา และนับให้ว่าใช้สิทธิ์ผ่านระบบไปแล้วกี่ครั้งจาก 5 ครั้ง ทุกคำตอบบอกที่มาได้

คู่มือการจัดบริการผดุงครรภ์ไทยแบบบูรณาการฯ พ.ศ. 2569 หน้า 100 ระบุว่าบริการนี้ควรมีระบบคลังยา ระบบคัดกรองอาการออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนทานยาและนัดหมายผ่าน LINE Official Account และคลังความรู้ดิจิทัล เรือนไฟทำ 3 ใน 4 ระบบนี้ให้ทำงานต่อกันในระบบเดียว

เรือนไฟเป็นเว็บแอปที่เปิดใช้ใน LINE และช่วยคน 3 กลุ่ม

- **คุณแม่** ได้คัดกรองก่อนออกจากบ้าน ปฏิทินส่วนตัว จองคิวได้เฉพาะหัตถการที่ผ่านเกณฑ์และยังเหลือสิทธิ์ เตือนทานยา และเช็กอินซ้ำจนครบ 3 เดือน
- **หน่วยบริการ** ตั้งตารางเวลาเองได้ ได้ใบสรุปก่อนคุณแม่มาถึง คำเตือนข้อห้ามตอนสั่งยา และคลังยาที่ตัดสต็อกตามการจ่ายจริง
- **กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กรมฯ)** ได้ภาพรวมผลลัพธ์ของทั้งเครือข่าย และข้อเสนอปรับปรุงบริการจาก AI ที่มีหลักฐานกำกับ

การตัดสินว่าคุณแม่เข้าเกณฑ์ข้อไหนใช้กฎที่เขียนตามคู่มือทั้งหมด ไม่ให้ AI ตัดสิน AI ทำงานกับข้อมูลรวมกลุ่มเท่านั้น คือวิเคราะห์ข้อมูลบริการเทียบกับคู่มือเพื่อเสนอแนวทางปรับปรุง และสรุปรีวิวหลังรับบริการ ทุกข้อเสนอต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญก่อนนำไปใช้

1. ปัญหาที่ต้องการแก้ (Pain Point)

1.1 มาตรฐานมีอยู่แล้ว แต่แต่ละที่ยังใช้ไม่เหมือนกัน

เอกสารองค์ความรู้ของการแข่งขัน (Knowledge Hub Track 3) ชี้ว่าปัญหาไม่ใช่การไม่มีมาตรฐาน แต่เป็น “**ช่องว่างระหว่างมาตรฐานที่กำหนดไว้กับมาตรฐานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยบริการ**” ทั้งเรื่อง “การคัดกรองข้อห้าม...เกณฑ์การหยุดให้บริการ เกณฑ์การส่งต่อ” (หน้า 5) และสรุปว่า “GAP สำคัญอยู่ที่ช่วงกลางน้ำและปลายน้ำ” (หน้า 9)

1.2 ฝั่งคุณแม่: ต้องนับหลายกรอบเวลา และหลายเรื่องรู้ได้เมื่อไปถึงหน่วยบริการ

ไม่รู้ว่าเริ่มได้เมื่อไรและหมดสิทธิ์เมื่อไร คลอดปกติเริ่มรับบริการได้หลังคลอด 2–7 วัน ผ่าคลอดต้องรอครบ 1 เดือน ทั้งสองแบบต้องไม่เกิน 3 เดือน (คู่มือฯ หน้า 78, 96) และหัตถการแต่ละอย่าง (เช่น นวด ประคบ อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ) ยังมีกรอบเวลาของตัวเอง เช่น ทับหม้อเกลือหลังคลอดปกติประมาณ 7 วัน แต่ผ่าคลอด 30 วัน (หน้า 92) ส่วนสิทธิบัตรทองให้รับชุดบริการฟื้นฟูหลังคลอดรวมไม่เกิน 5 ครั้งภายใน 3 เดือน และไม่เกินวันละครั้ง (Knowledge Hub หน้า 4)

ไม่รู้ว่าโรคหรืออาการที่มีเกี่ยวข้อง คู่มือมีเกณฑ์คัดออก 10 ข้อ เช่น เบาหวานที่ยังคุมไม่ได้ และเกณฑ์ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน 7 ข้อ เช่น น้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็น (หน้า 78–79) ถ้าไม่รู้ คุณแม่อาจไปโรงพยาบาลช้ากว่าที่ควร

วันนี้ผ่าน ไม่ได้แปลว่าสัปดาห์หน้าจะยังปลอดภัย อาการหลังคลอดเปลี่ยนได้ตลอด การคัดกรองครั้งเดียวจึงไม่พอ

1.3 ฝั่งหน่วยบริการ: ต้องซักถามหน้างาน และตรวจข้อห้ามยาเองทุกครั้ง

คำถามคัดกรองส่วนใหญ่ตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่ จึงถามล่วงหน้าได้ แต่ในแผนผังมาตรฐาน การคัดกรองเป็นขั้นแรกเมื่อมาถึงหน่วยบริการ (รูปที่ 4.3 หน้า 102) และต้องตรวจสอบสิทธิทุกครั้ง (หน้า 108) ส่วนการจ่ายยาสมุนไพรต้องตรวจข้อห้ามตามตารางที่ 4.1 *ทีมตั้งสมมติฐานว่าบางคนจึงมาแล้วรับบริการไม่ได้ แต่ยังไม่พบข้อมูลที่นับเรื่องนี้ (ข้อ 5.4)*

1.4 ระดับประเทศ: ยังไม่มีใครเห็นว่าผลลัพธ์โดยรวมเป็นอย่างไร

Knowledge Hub ข้อ 10 ระบุว่าปัจจุบันมีระบบรองรับการเบิกจ่ายแล้ว แต่ข้อมูลว่า “ให้บริการกี่ครั้ง” ยังตอบไม่ได้ว่าบริการทำให้สุขภาพดีขึ้นหรือไม่ จึงควรติดตามผลลัพธ์ เช่น ความปวดก่อนและหลังบริการ ความพึงพอใจ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (หน้า 8)

2. แนวทางการแก้ไข (Solution)

2.1 หลักการ

1. **คัดกรองก่อนจอง** คุณแม่จองได้เฉพาะหัตถการที่ผ่านเกณฑ์ อยู่ในกรอบเวลา และยังเหลือสิทธิ์ หัตถการที่ต้องประเมินก่อนจองได้เป็น “นัดประเมิน”

2. **คนเป็นผู้ตัดสิน ระบบทำหน้าที่แค่ชี้** ตรงกับคู่มือที่ระบุว่าการใช้หัตถการ “ต้องดำเนินการภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษา” (หน้า 93)
3. **ไม่แน่ใจ = ให้คนประเมิน** ตอบ “ไม่แน่ใจ” แล้วเล่าเพิ่มได้ ระบบถือว่าต้องประเมินก่อน และส่งข้อความให้ผู้ประกอบวิชาชีพอ่าน
4. **ทุกคำตอบบอกที่มาได้** กฎทุกข้อมีเลขหน้าของคู่มือและเลขเวอร์ชันกำกับ
5. **ข้อมูลไม่ถูกส่งไปไหน ถ้าเจ้าของไม่อนุญาต**

2.2 ข้อค้นพบหลัก: ผ่าคลอดไม่ใช่แค่ต้องรอนานกว่า แต่ทำหัตถการได้คนละชุด



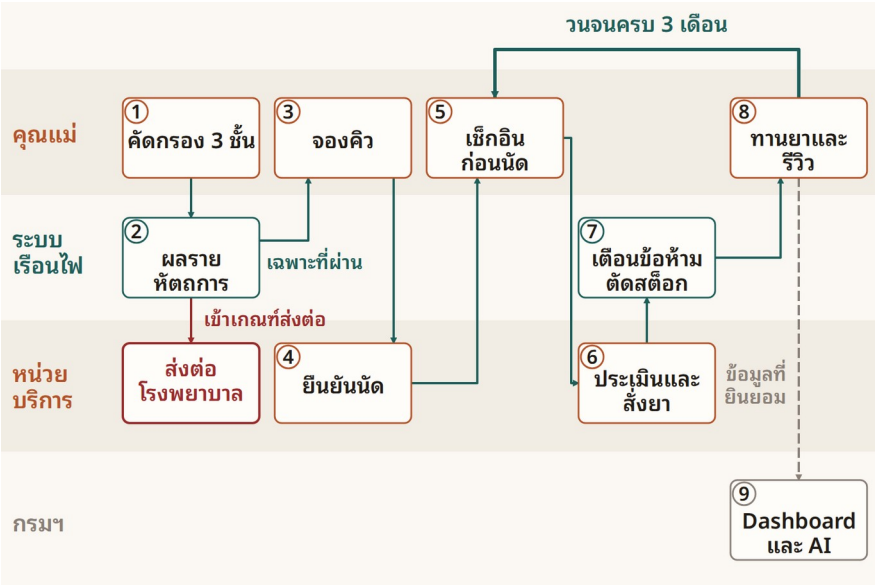
ภาพที่ 1 — คุณแม่สองคนคลอดวันเดียวกัน คนหนึ่งคลอดปกติ อีกคนผ่าคลอด หัตถการที่ทำได้ต่างกันตลอดทั้งเส้นทาง

สำหรับคนที่ผ่าคลอด คู่มือกำหนดว่าอบสมุนไพรไม่ได้ถ้าแผลยังไม่หายสนิท (หน้า 93) ทับหม้อเกลือต้องรอ 30 วัน (หน้า 92) ห้ามใช้ก้อนเส้า (คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพมารดาและทารกฯ หน้า 123) และห้ามยาสมุนไพร 6 ตำรับในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ตารางที่ 4.1) **ระบบจึงแสดงผลและเปิดให้จองเป็นรายหัตถการ แทนการตอบรวมว่าผ่านหรือไม่ผ่าน**

2.3 เส้นทางการดูแลต่อเนื่อง 3 เดือน

1. **ตั้งโปรไฟล์และคัดกรองครั้งแรก 3 ชั้น** อาการที่ต้องไปโรงพยาบาล ภาวะที่อาจทำให้รับบริการไม่ได้ และข้อห้ามรายหัตถการ ถามตามเกณฑ์ส่งต่อ 7 ข้อและเกณฑ์คัดออก 10 ข้อ เฉพาะข้อที่คุณแม่ตอบเองได้ (หน้า 78–79, 91–93) ส่วนเรื่องที่ต้องตรวจร่างกาย เช่น มดลูกเข้าอู่ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพตรวจ

2. **ส่งต่อ หรือจองคิว** ถ้าเข้าเกณฑ์ส่งต่อ ระบบแสดงปุ่มโทร 1669 และโทรหน่วยบริการ และปิดการจองไว้ก่อน ถ้าไม่เข้า คุณแม่เลือกหน่วยบริการ หัตถการที่ระบบอนุญาต (หลายอย่างในครั้งเดียวได้) และเวลาว่างจากตารางที่ผู้ประกอบวิชาชีพตั้งเอง ระบบนับสิทธิ์ที่ใช้ไปให้
3. **เช็กอินก่อนวันนัด 1 วัน** ถาม 5 ข้อเรื่องอาการอันตรายที่คุณแม่สังเกตเองได้ ถ้าคำตอบเปลี่ยน นัดจะเปลี่ยนเป็น “รอประเมิน” และแจ้งหน่วยบริการทันที
4. **วันรับบริการ** เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ ผู้ประกอบวิชาชีพเปิดใบสรุป ตัดสินรายหัตถการ บันทึกความปวดก่อนและหลัง และสั่งยา ระบบเตือนข้อห้าม ตัดสต็อก และสร้างตารางเตือนทานยาให้คุณแม่
5. **รีวิวหลังรับบริการ** แล้ววนกลับไปเช็กอินและนัดครั้งถัดไป จนครบ 3 เดือน



ภาพที่ 2 — เส้นทางตั้งแต่คัดกรองจนติดตามผล จุดสำคัญคือประตูคัดกรองก่อนจองคิว และวงเช็กอินที่วนกลับมาจนครบ 3 เดือน

2.4 หน้าจอของผู้ใช้ 3 กลุ่ม

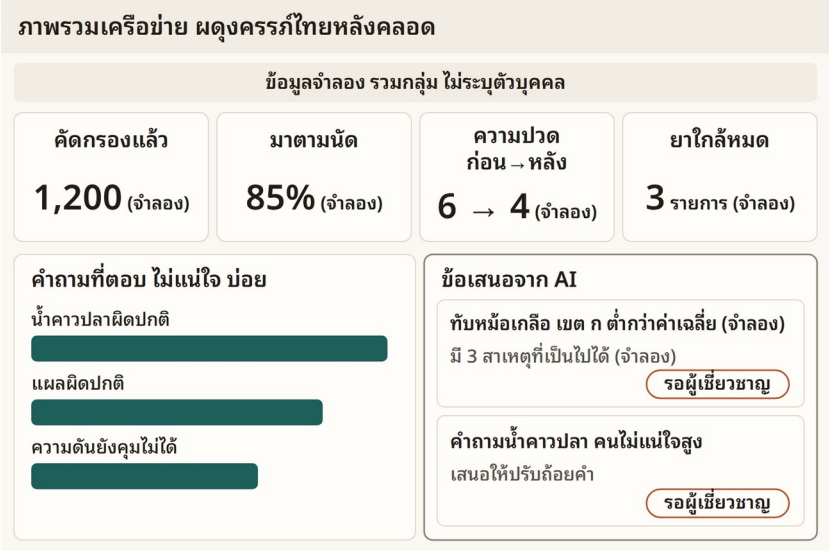
- **คุณแม่** (ภาพที่ 3) เห็นผลรายหัตถการ เลือกวันเวลาได้เฉพาะช่วงที่ทำได้ เห็นจำนวนสิทธิ์ที่ใช้ไป และเช็กอินก่อนนัด
- **หน่วยบริการ** (ภาพที่ 4) ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละคนตั้งตารางเวลาเองได้ ใบสรุปเรียงตามหัวข้อซักประวัติของคู่มือ (หน้า 79, 97) และคลังยาแจ้งเตือนเมื่อยาใกล้หมดหรือใกล้หมดอายุ
- **กรมฯ** (ภาพที่ 5) เห็นเฉพาะข้อมูลที่ยินยอมและรวมกลุ่มแล้ว ช่องที่มีน้อยกว่า 5 คนจะซ่อนตัวเลข ตัวชี้วัดครอบคลุมผลลัพธ์ตาม Knowledge Hub ข้อ 10 ความปลอดภัย การเข้าถึงบริการแยกหน่วยและเขต และยา ตัวชี้วัดใหม่คือ **คำถามที่คุณแม่ตอบ “ไม่แน่ใจ” บ่อยที่สุด** ซึ่งบอกได้ว่าเกณฑ์ข้อไหนที่คนทั่วไปเข้าใจยาก



ภาพที่ 3 — หน้าจอคุณแม่ ซ้าย: ผลรายหัตถการพร้อมปุ่มจองคิว กลาง: เลือกวันเวลาเฉพาะช่วงที่ทำได้ พร้อมจำนวนสิทธิ์ที่ใช้ไป ขวา: เช็กอินที่มีช่องให้เล่าเมื่อไม่แน่ใจ



ภาพที่ 4 — หน้าจอหน่วยบริการ คิววันนี้ ใบสรุปเคสที่เน้นคำตอบ “ไม่แน่ใจ” การสั่งยาพร้อมคำเตือนข้อห้าม และสต็อกคงเหลือ



ภาพที่ 5 — ตัวอย่าง Dashboard ระดับเครือข่ายสำหรับกรมฯ ใช้ข้อมูลจำลองเพื่อการสาธิตเท่านั้น

2.5 ช่องทาง: เว็บแอปบน LINE Official Account

คุณแม่ใช้ผ่าน LINE ไม่ต้องโหลดแอปใหม่ หน่วยบริการและกรมฯ ใช้ผ่านเว็บไซต์ กติกามี 3 ข้อ

1. **ห้องแชทใช้แจ้งเตือนอย่างเดียว** ข้อความไม่มีชื่อโรค ชื่อยา หรือผลคัดกรอง มีแค่ปุ่มพาเข้าหน้าเว็บ เพราะคนที่ใช้มือถือเครื่องเดียวกันอาจเปิดอ่านแชทได้
2. **ปุ่มติดต่อฉุกเฉินอยู่บนหน้าจอตลอดเวลา**
3. **คุณแม่เลือกรูปแบบเตือนทานยาได้** รับเตือนทุกรอบตามใบสั่ง หรือสรุปวันละครั้ง เพื่อไม่ให้รบกวนเกินจำเป็น และคุมค่าส่งข้อความ

3. การประยุกต์ใช้ AI และเทคโนโลยี

3.1 หลักการ: AI ช่วยกรมฯ และหน่วยบริการ แต่ไม่ตัดสินเรื่องคนไข้

ส่วน	ใช้อะไร	เหตุผล
คัดกรอง กรอบเวลา นัดหมาย และคำเตือนข้อห้ามยา	**กฎที่เขียนตามคู่มือ ไม่ใช้ AI**	ผลต้องเหมือนเดิมทุกครั้งและบอกที่มาได้
วิเคราะห์ข้อมูลบริการเทียบกับคู่มือ	AI-1 เสนอ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา	ข้อมูลทั้งเครือข่ายมากเกินกว่าคนอ่านทัน
สรุปรีวิวหลังรับบริการ	AI-2 จัดกลุ่มเป็นธีม	รีวิวเป็นข้อความอิสระ

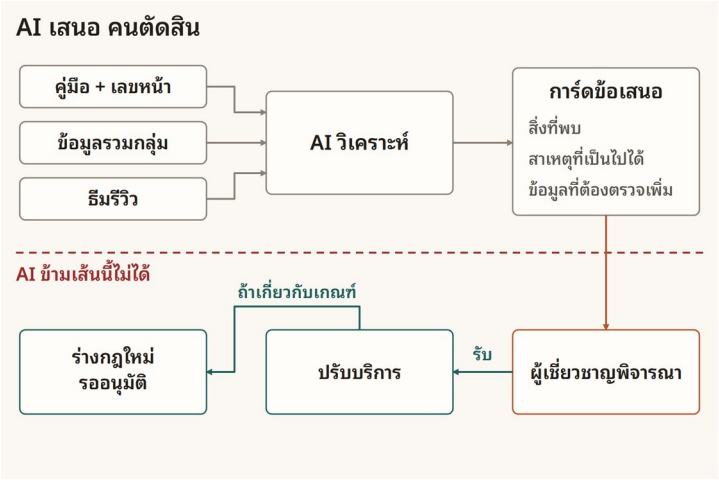
3.2 AI-1 ผู้ช่วยวิเคราะห์บริการ

AI-1 เทียบคู่มือ (ชุดกฎและข้อความพร้อมเลขหน้า) กับตัวเลขรวมกลุ่มจาก Dashboard แล้วสร้าง “การ์ดข้อเสนอ” ที่บอกสิ่งที่พบ สิ่งที่คู่มือระบุ สาเหตุที่เป็นไปได้อย่างน้อย 2 ข้อ ข้อเสนอ ข้อมูลที่

ต้องตรวจเพิ่ม และระดับความมั่นใจ แนวทางนี้ตรงกับที่บทสรุปผู้บริหารของคู่มือให้ติดตามและประเมินผล “เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาปรับปรุงมาตรฐาน”

ตัวอย่าง (ข้อมูลจำลอง): ทับหม้อเกลือในเขตหนึ่งน้อยกว่าเขตอื่นมาก อาจเพราะสัดส่วนผ่าคลอดสูง ไม่มีอุปกรณ์ หรือบันทึกไม่ครบ จึงเสนอให้ตรวจทั้งสามเรื่องก่อนสรุป

ตัวเลขที่ต่างเป็นเพียงสมมติฐาน AI จึงต้องเสนอหลายสาเหตุเสมอ และ **ห้ามเสนอเปลี่ยนเกณฑ์ทางคลินิกเอง** ทำได้แค่ส่งเป็นประเด็นให้ผู้เชี่ยวชาญทบทวน ทุกการเปลี่ยนชุดกฎต้องผ่านผู้อนุมัติและบันทึกเลขเวอร์ชัน



ภาพที่ 6 — AI อ่านข้อมูลรวมกลุ่ม รีวิว และคู่มือ แล้วสร้างข้อเสนอพร้อมหลักฐาน ผู้เชี่ยวชาญต้องพิจารณาก่อนนำไปใช้

3.3 AI-2 วิเคราะห์รีวิวหลังรับบริการ

คุณแม่ให้คะแนน 4 ด้าน บอกระดับความปวด และเขียนความเห็นได้ AI-2 ลบข้อมูลระบุตัวตนก่อน แล้วจัดกลุ่มเป็นธีม เช่น การอธิบาย เวลารอ ความสะอาด สรุปรายเดือนระดับหน่วยบริการ ไม่จัดอันดับผู้ประกอบวิชาชีพรายคน **ถ้าข้อความบ่งบอกอาการไม่พึงประสงค์ เช่น ผิวพองหลังประคบ ระบบส่งให้เจ้าหน้าที่ตามต่อทันที**

สิ่งที่ AI ทั้งสองตัวห้ามทำ วินิจฉัยโรค ตัดสินว่าคุณแม่เข้าเกณฑ์ข้อไหน อ่านหรือแปลความข้อความ “ไม่แน่ใจ” ของคุณแม่ เปลี่ยนกฎหรือเส้นทางส่งต่อเอง และเห็นข้อมูลรายคน

3.4 โครงสร้างระบบ

- **ชุดกฎ** เก็บเป็นข้อมูลที่มีเลขเวอร์ชันและเลขหน้า แก้ได้โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม ทุกเคสบันทึกว่าใช้กฎเวอร์ชันไหน
- **นัดหมาย ยา และคลังยา** ใช้โครงเดียวกัน คือตารางเวลาของหน่วยบริการ ใบสั่งยา และรายการเคลื่อนไหวของสต็อก ต้นแบบใช้ข้อมูลจำลอง การเชื่อมกับระบบของโรงพยาบาลต้องทำร่วมกับหน่วยบริการแต่ละแห่ง

- **โมเดลภาษา (LLM)** ตัวเลขทุกตัวคำนวณด้วยโปรแกรม LLM ใช้แค่เขียนคำอธิบาย ต้นแบบใช้ LLM เชิงพาณิชย์กับข้อมูลจำลอง ใช้งานจริงเสนอโมเดลภาษาไทยแบบเปิด เช่น Typhoon หรือ Pathumma LLM บนเซิร์ฟเวอร์ภาครัฐ (เอกสารอ้างอิง 5)
- **ข้อมูลส่วนบุคคล** ข้อมูลสุขภาพต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26) จึงแยกความยินยอม 2 ชั้น (เพื่อรับบริการ และเพื่อใช้แบบรวมกลุ่ม) ถอนได้ทุกเมื่อ บันทึกทุกครั้งที่มีคนเปิดใบสรุป และไม่นำไปใช้ฝึก AI

4. ความสอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนไทย

4.1 คู่มือของกรมฯ ระบุว่าต้องการระบบนี้

4) ระบบข้อมูล/SOP (Health information systems / SOP)	4.1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมกำกับมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก: (1) ระบบบริหารจัดการคลังยา (2) ระบบสนับสนุนการให้บริการและการติดตามการรักษา ได้แก่ - ระบบคัดกรองอาการออนไลน์ - ระบบแจ้งเตือนและนัดหมายอัตโนมัติ: แจ้งเตือนการรับประทานยาตามรอบ และนัดหมายทำหัตถการผ่านแอปพลิเคชันหรือ LINE Official Account - คลังความรู้ดิจิทัล (E-Manual): รวบรวมข้อมูลวิดีโอสาธิตการใช้ยาสมุนไพรและการดูแลตนเองที่ปลอดภัย เพื่อลดความคลาดเคลื่อนใน

ภาพที่ 7 — คู่มือฯ 2569 ตารางที่ 4.2 หน้า 100 องค์ประกอบ “ระบบข้อมูล/SOP (Health information systems / SOP)”

คู่มือหน้า 100 ระบุ	เรือนไฟในต้นแบบรอบนี้
ระบบบริหารจัดการคลังยา	**ทำ** สต็อก รับเข้า จ่ายออก วันหมดอายุ เชื่อมกับใบสั่งยา
ระบบคัดกรองอาการออนไลน์	**ทำ** คัดกรอง 3 ชั้นและเช็กอินซ้ำ
ระบบแจ้งเตือนและนัดหมายอัตโนมัติ (เตือนทานยาตามรอบ และนัดหมายหัตถการผ่าน LINE Official Account)	**ทำ** เตือนยาจากใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพ และจองคิวตามตารางของหน่วยบริการ
คลังความรู้ดิจิทัล (E-Manual)	**ยังไม่ทำ** (แสดงได้แค่ที่มาของเกณฑ์)

4.2 ต่อกับรหัสโรคและการเบิกจ่ายที่มีอยู่แล้ว

คู่มือกำหนดรหัส ICD-10-TM ระยะหลังคลอดไว้แล้ว เช่น U50.2 น้ำคาวปลาไม่เดิน และ U50.3 อยู่ไฟไม่ได้ (หน้า 105–106) และรายการเบิกจ่าย 6 รายการ (หน้า 100–101) ผู้ประกอบวิชาชีพเลือกรหัสจากรายการนี้เองในหน้าบันทึกการรักษา ระบบนับครั้งตามโควตาบัตรทอง และให้เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตรวจสอบสิทธิแล้ว (หน้า 108) *ตัวนับเห็นเฉพาะครั้งที่ผ่านเรือนไฟ จึงใช้แทนการตรวจสิทธิในระบบของ สปสช. ไม่ได้*

4.3 ตอบช่องว่างที่ Knowledge Hub ระบุไว้

- **ข้อ 2 แต่ละที่คัดกรองข้อห้ามไม่เหมือนกัน (หน้า 5)** ใช้กฎชุดเดียวกันทุกเคส และ Dashboard แสดงความต่างระหว่างหน่วยบริการ
- **ข้อ 4 ต้องมีระบบส่งต่อที่ชัดเจน (หน้า 6)** ถามตามเกณฑ์ส่งต่อของคู่มือ และปิดการจองจนกว่าจะได้คุยกับผู้ประกอบวิชาชีพ
- **ข้อ 10 เปลี่ยนจากนับจำนวนครั้งเป็นดูผลลัพธ์ (หน้า 8)** ติดตามความปวด ความพึงพอใจ การกลับมาซ้ำ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 ข้อเสนอ: ใครจะดูแลระบบต่อหลังจบการแข่งขัน

ทีมเสนอให้**กรมฯ เป็นเจ้าของระบบ** และเปิดให้หน่วยบริการใช้ร่วมกัน กรมฯ มีประกาศ (ร่าง) จ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางด้วย AI (เอกสารอ้างอิง 4) เรือนไฟแยกชุดกฎ นัดหมาย และคลังยาเป็นส่วน ๆ จึงต่อเป็นส่วนเสริมได้ กลุ่มที่อาจใช้นำร่องคือหน่วยบริการ 35 แห่งที่ทดลองใช้คู่มือแล้ว (หน้า 118–119) *ทีมยังไม่ทราบขอบเขตของแพลตฟอร์มกลาง และยังไม่ได้ติดต่อหน่วยบริการเหล่านี้*

5.2 ขอบเขตของต้นแบบ

- **ต้องมี** คัดกรอง ปฏิทิน จองคิวพร้อมประตูคัดกรองและตัวนับสิทธิ์ ตารางเวลาหน่วยบริการ เช็กอินซ้ำ ใบสรุปเคส สั่งยาพร้อมคำเตือน เตือนทานยา ตัดสต็อก ฟอร์มรีวิว หน้าภาพรวม Dashboard และการ์ดข้อเสนอจาก AI-1 (ข้อมูลจำลอง)
- **ควรมี** รับยาเข้าคลังพร้อม Lot และวันหมดอายุ AI-2 สรุปรีวิว และ Dashboard ครบทุกหน้า
- **ไม่ทำในรอบนี้** วินิจฉัยโรค แนะนำยาหรือหัตถการรายบุคคล ชำระเงิน เชื่อมระบบจริงของหน่วยงาน คลังความรู้ และระยะตั้งครรภ์

5.3 ตัวชี้วัดที่เสนอ

- **ช่วงทดสอบ** ผู้ใช้คัดกรองและจองคิวจนจบได้เอง ผู้ที่เข้าเกณฑ์ส่งต่อเลือกติดต่อโรงพยาบาลได้ถูก และผู้ใช้เข้าใจว่าผลคัดกรองไม่ได้แปลว่าปลอดภัย
- **ช่วงใช้งานจริง** สัดส่วนคนที่มาถึงแล้วรับบริการไม่ได้ (ควรลดลง) ความปวดก่อนและหลัง การไม่มาตามนัด ยาขาดสต็อก และความพึงพอใจ

5.4 หลักฐานที่มี และสิ่งที่ยังต้องพิสูจน์

ทีมยังไม่ได้สัมภาษณ์ผู้ใช้ จึงค้นงานวิจัยและเอกสารสาธารณะแทน (26 ก.ย. 2569)

- **มีหลักฐานรองรับ** งานสำรวจหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด 485 คนใน 4 โรงพยาบาลของกรุงเทพฯ มีเพียงร้อยละ 21 ที่รู้ว่าบัตรทองใช้รับบริการฟื้นฟูหลังคลอดด้วยการแพทย์แผน

ไทยได้ฟรี และบางคนเข้าใจผิดว่าผ่าคลอดหรือทำหมันแล้วใช้บริการไม่ได้ (เอกสารอ้างอิง 6) ส่วนวันเริ่มหลังผ่าคลอด ศูนย์การแพทย์แห่งหนึ่งระบุ 30–45 วัน ต่างจากคู่มือที่ระบุ 1 เดือน (เอกสารอ้างอิง 7)

- **ยังไม่พบหลักฐาน** ว่ามีคนมาถึงแล้วรับบริการไม่ได้มากแค่ไหน ภาระคัดกรองของผู้ประกอบวิชาชีพ และความแม่นของการรายงานอาการเองของคุณแม่ไทย จึงต้องวัดตั้งแต่นำร่อง
- **เรือนไฟไม่ได้แก้** เหตุผลหลักที่คุณแม่ไม่ตั้งใจใช้บริการ คือไม่มีคนดูแลลูก (เอกสารอ้างอิง 6)

สิ่งที่ทีมปรับตามหลักฐาน (1) วันเริ่มใช้ค่าจากคู่มือเป็นขั้นต่ำ หน่วยบริการตั้งให้ช้ากว่านั้นได้ตามดุลยพินิจแพทย์ (หน้า 78) (2) เพดาน 5 ครั้งเป็นตัวเลขจาก Knowledge Hub ทีมยังไม่พบประกาศ สปสช. ปีงบ 2569 ฉบับเต็ม จึงเก็บเป็นค่าในชุดกฎที่แก้ได้ (3) หมอพร้อมจองคิวผ่าน LINE ได้แล้ว (เอกสารอ้างอิง 8) จึงเสนอเรือนไฟเป็นส่วนเสริมของระบบที่มีอยู่ (ข้อ 5.1)

ก่อนใช้จริง เกณฑ์และถ้อยคำที่ทีมร่างจากคู่มือ**ยังไม่ผ่านการตรวจ** ทีมจะให้ผู้ประกอบวิชาชีพผดุงครรภ์ไทยตรวจ บุคลากรแม่และเด็กตรวจเส้นทางส่งต่อ และผู้ใช้ 3–5 คนทดสอบ **ทีมจะหยุดและแก้ก่อน** ถ้าการส่งต่อช้าลง หรือผู้ใช้ตอบอาการเบากว่าความจริงเพื่อให้จองได้

5.5 ทีม

นายธนพัชร์ บูรณะรักษ์ธรรม (เกรพ) Product และผู้นำเสนอหลัก | นายพันธวัช อินสุพัตรา (พู) AI และ Backend | นายฐานิศร์ จรูญสิริเศรษฐ์ (ออฟ) UX/UI Design

เอกสารอ้างอิง

1. คู่มือการจัดบริการผดุงครรภ์ไทยแบบบูรณาการในระบบบริการสุขภาพ — กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฉบับที่ 1 สิงหาคม 2569 ISBN 978-616-11-5815-6
2. Knowledge Hub Track 3 ผดุงครรภ์ไทย — DTAM Thai Traditional Medicine Digital Health & AI
3. คู่มือแนวทางการดูแลสุขภาพมารดาและทารกด้วยการแพทย์แผนไทย — สถาบันการแพทย์แผนไทย
4. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, (ร่าง) ประกาศจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางฯ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, 9 มี.ค. 2569 — https://www.dtam.moph.go.th/e-bidding/42541/
5. Typhoon 2 ของ SCB 10X (10 ม.ค. 2568) https://huggingface.co/scb10x และ Pathumma LLM ของ NECTEC (4 มิ.ย. 2568) https://www.nectec.or.th/innovation/innovation-service/pathumma-llm.html
6. Sirichai L และคณะ, Factors influencing the intention to use Thai traditional medical postpartum care among pregnant and postpartum women in Bangkok, BMC Complement Med Ther 2025;25:214 (1 ก.ค. 2568) https://doi.org/10.1186/s12906-025-04960-5
7. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, ประโยชน์ของการดูแลมารดาหลังคลอด, 15 เม.ย. 2563 https://www.gj.mahidol.ac.th/main/afterbirth/
8. กระทรวงสาธารณสุข, หมอพร้อม (เข้าถึง 26 ก.ย. 2569) https://mohpromt.moph.go.th/